全麻清醒后、腰麻 6 小时后：

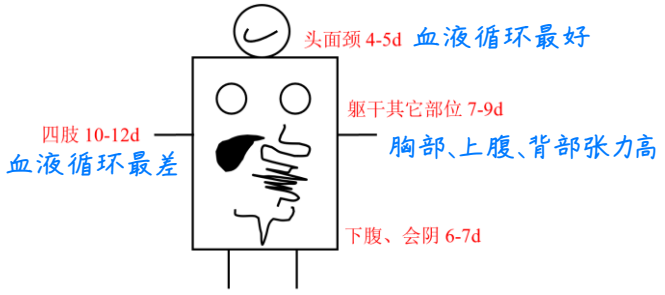
颅脑手术	头高脚低斜坡卧位 防止脑水肿
颈、胸手术（食管癌等）	**高半**坐位
腹部手术（胃大部切除术等）	**低半**坐位
腹腔内有污染	半坐/卧或头高脚低位 把脓液集中在盆腔
休克	**头和躯干抬高 20-30 度、下肢抬高 15-20 度** 增加回心血量

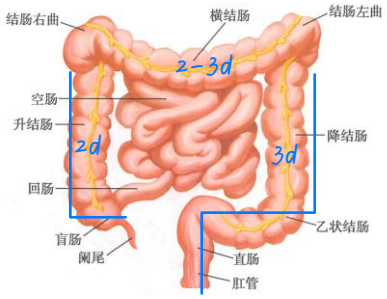
继发性腹膜炎半卧位:①盆腔膜吸收最差,避免吸收入血②集中引流③避免膈肌受压,利于呼吸循环

（二）拆线和拔管

1.**拆线**：头面颈 4-5d、下腹/会阴 6-7d、躯干其它部位 7-9d、四肢 10-12d、减张缝合 14d

（双 11 剁手、心痛吧、我头痛死、起来遛下会阴、剪了要死）





2.拔管：乳胶片 1-2d、烟卷引流 3d、**T 管 4 周**

术后2周T管造影→胆道通畅,继续引流1天后闭管→至少等4周才可以拔管/取石

（三）并发症

①发热（最常见）：术后 1.4 天吸收热、输血输液等；术后 2.7 天感染可能大

②低体温

③肺膨胀不全、感染、肺栓塞：术后肺部并发症和死亡率仅次于心血管系统居第二位

④尿潴留：协助病人自行排尿→导尿→导尿量＞500ml 留置尿管 1-2 天（骶前神经损伤或前列腺肥大留置 4-5 天）

尿感发生率:留置尿管1天:50%;留置超过3天:90%以上,所以尽量不留置尿管

⑤出血：腹腔手术 24 小时内休克考虑内出血，胸腔手术引流管引出血液量持续≥100ml/h 考虑内出血

⑥胃肠蠕动减弱：胃、结肠蠕动显著减弱，右半结肠需 2 天、左半结肠需 3 天、胃和空肠需 2-3 天恢复

